UNIGRANDE CENTRO

Avaliação Postural e da Marcha

Um Guia Visual para o Diagnóstico Clínico e Estrutural

Prof.: João Paulo Campos de Souza

Gemini Notebook

O Propósito da Avaliação



A avaliação da postura e da marcha é o o alicerce da fisioterapia.
O reconhecimento de padrões de movimento e desvios estáticos permite decodificar o corpo do paciente.

Diagnóstico Fisioterapêutico

Identificar alterações resultantes de disfunções, doenças estruturais ou assimetrias articulares.

Plano de Tratamento

Fornecer os dados biomecânicos exatos necessários para desenhar a intervenção clinica correta.

Gemini Notebook

O Espectro do Alinhamento: Eficiência vs. Estresse



Postura Correta

Máxima eficiência fisiológica e biomecânica.

Mínimo estresse imposto sobre cada articulação.

Atividade muscular necessária é mínima.



Postura Defeituosa

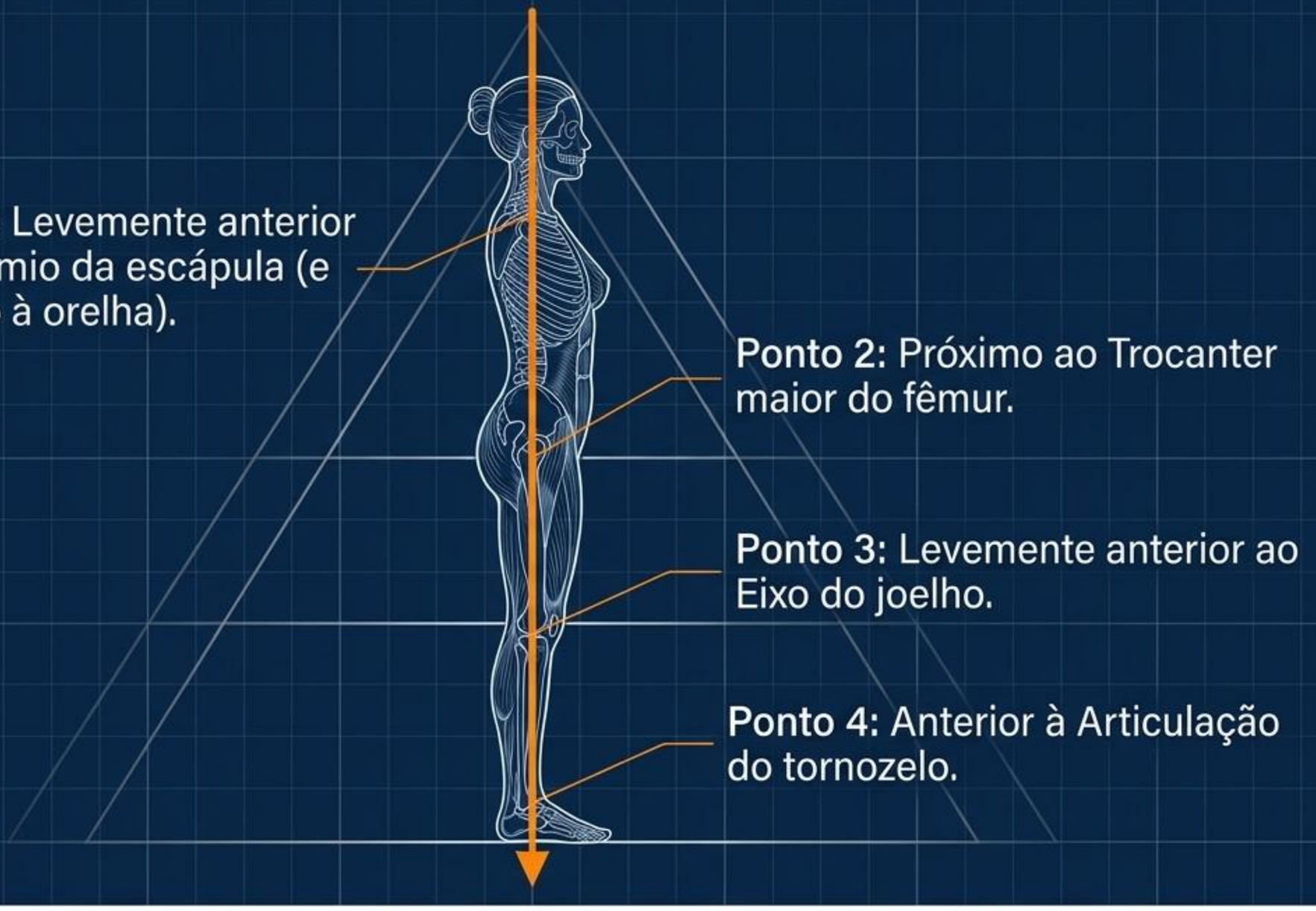
Alinhamento assimétrico e compensatório.

Aumento drástico do estresse mecânico sobre as articulações.

Sobrecarga das estruturas de suporte e adaptação muscular constante.

Gemini Notebook

O Padrão Ouro: Pontos de Referência da Postura Ideal



Ponto 1: Levemente anterior ao Acrômio da escápula (e próximo à orelha).

Ponto 2: Próximo ao Trocanter maior do fêmur.

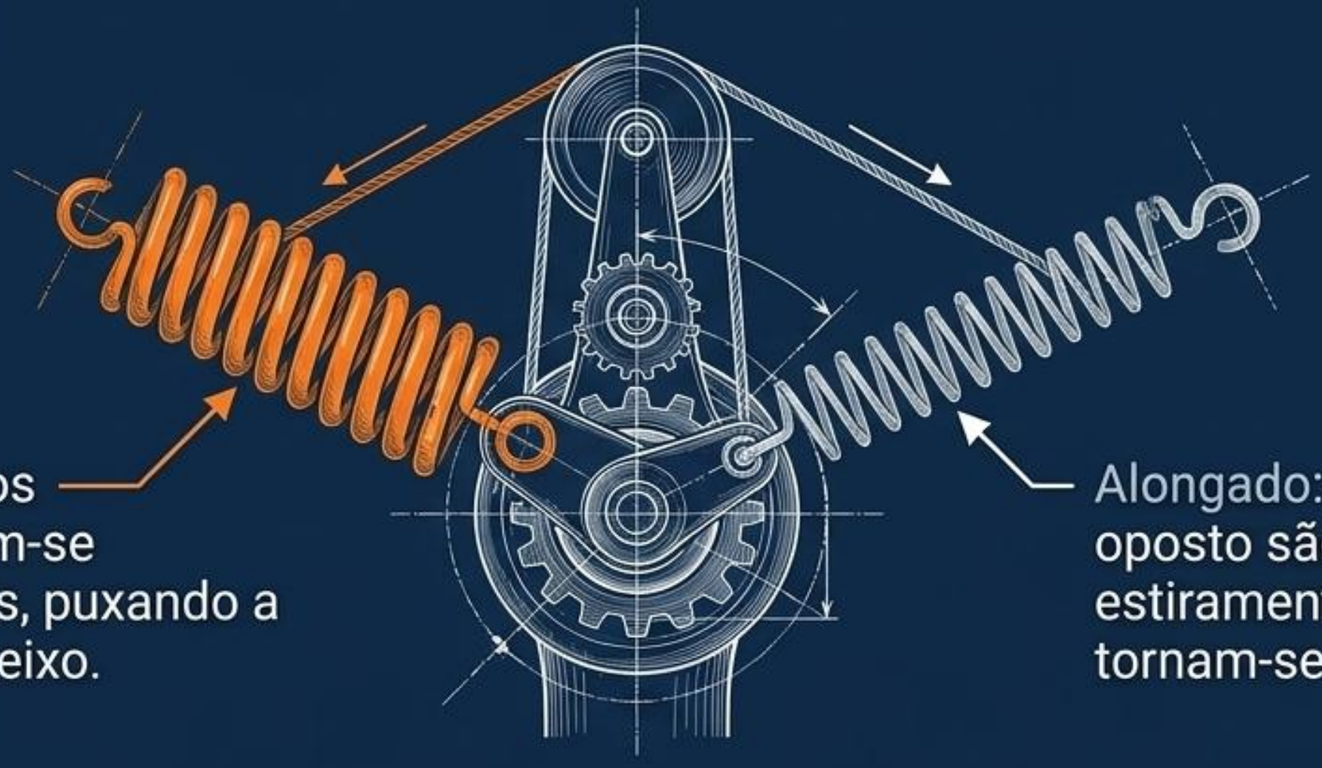
Ponto 3: Levemente anterior ao Eixo do joelho.

Ponto 4: Anterior à Articulação do tornozelo.

O alinhamento perfeito minimiza a tensão transmitida ao sistema de suporte corporal.

Gemini Notebook

A Biomecânica do Desalinhamento



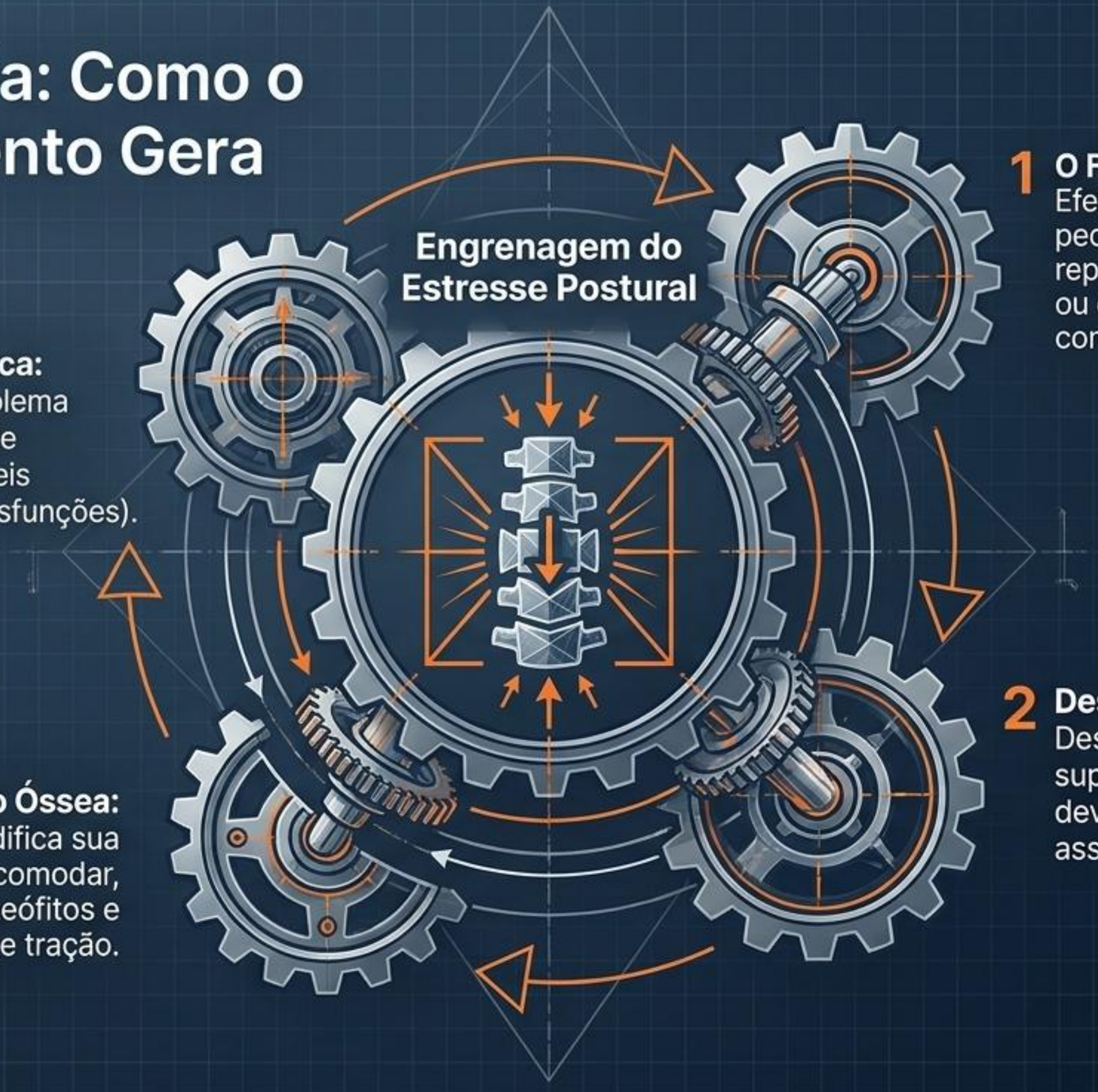
Encurtado: Músculos antagonistas tornam-se encurtados e rígidos, puxando a articulação fora do eixo.

Alongado: Músculos do lado oposto são mantidos em estiramento constante e tornam-se alongados/fracos.

Esta assimetria causa deficiências articulares severas, incluindo debilidade muscular e amplitude de movimento limitada. O corpo não consegue mudar a postura prontamente para corrigir o estresse.

Gemini Notebook

Fisiopatologia: Como o Desalinhamento Gera a Doença



1 O Fator Desencadeante:
Efeito cumulativo de pequenos estresses de repetição (Microtraumas) ou estresses agudos e constantes (Macrotraumas).

2 Desgaste Estrutural:
Desgaste excessivo das superfícies articulares devido à pressão assimétrica.

3 Adaptação Óssea:
O corpo modifica sua estrutura para se acomodar, produzindo osteófitos e esporões de tração.

4 Manifestação Clínica:
Exacerbação do problema original e produção de sinais/sintomas visíveis (queixas de dores, disfunções).

Gemini Notebook

O Fluxo de Avaliação Clínica

Anamnese
(A Fundação)

Coleta de dados históricos e contextuais.

Inspeção
(O Mapa Estrutural)

A etapa central. Observação tridimensional rigorosa das assimetrias.

Testes Adicionais
(A Validação)

Manobras específicas para quantificar e confirmar as hipóteses da inspeção.

Gemini Notebook

Pilar 1: Anamnese Estratégica

História do Problema

Identificar quando a queixa musculoesquelética começou e a natureza dos sintomas (agudo vs. crônico).

Condição de Saúde

Mapear patologias subjacentes e nível de atividade física. Músculos fortes e flexíveis podem mascarar desalinhamentos.

Histórico Familiar

Identificar predisposições a condições estruturais congênitas ou hereditárias.



Muitos pacientes buscam alívio para sintomas sem saber que precisam de avaliação postural. O fisioterapeuta deve conectar a queixa à estrutura subjacente.

Gemini Notebook

Pilar 2: Regras de Ouro da Inspeção Visual

1 

Preparo do Paciente: O paciente deve estar despido de calçados, vestindo apenas roupas de banho, permitindo a visualização limpa de toda a cadeia muscular e óssea.

2 

A Posição Base: Observação inicial com o paciente em pé (postura vertical ereta), estabelecendo um eixo gravitacional primário.

3 

Observação Tridimensional: A postura não é plana. Exige mapeamento rigoroso em três vistas: Anterior, Lateral e Posterior.

Nota de Alerta: A postura ereta é o ponto de partida, mas a avaliação da dinâmica de movimento do paciente é essencial para um quadro clínico completo.

Gemini Notebook

Matriz de Inspeção Tridimensional

Vista Anterior (A Frente)	Vista Lateral (O Perfil)	Vista Posterior (As Costas)
Indicadores Globais: Torcicolo, escoliose, inclinação pélvica lateral. **Membros Inferiores:** Coxa valga/vara, torção tibial/femoral, joelho valgo/varo, hálux valgo.	**Indicadores Globais:** Cabeça anteriorizada, lordose excessiva. **Membros Inferiores:** Inclinação pélvica anterior/posterior, retroversão ou retrotorção tibial.	**Indicadores Globais:** Escoliose. **Membros Inferiores:** Retropé varo/valgo, supinação subtalar excessiva (calcâneo varo), pronação subtalar excessiva (calcâneo valgo), antepé varo.

Gemini Notebook

Tolerâncias Anatômicas: O Que Procurar

Cabeça & Cervical

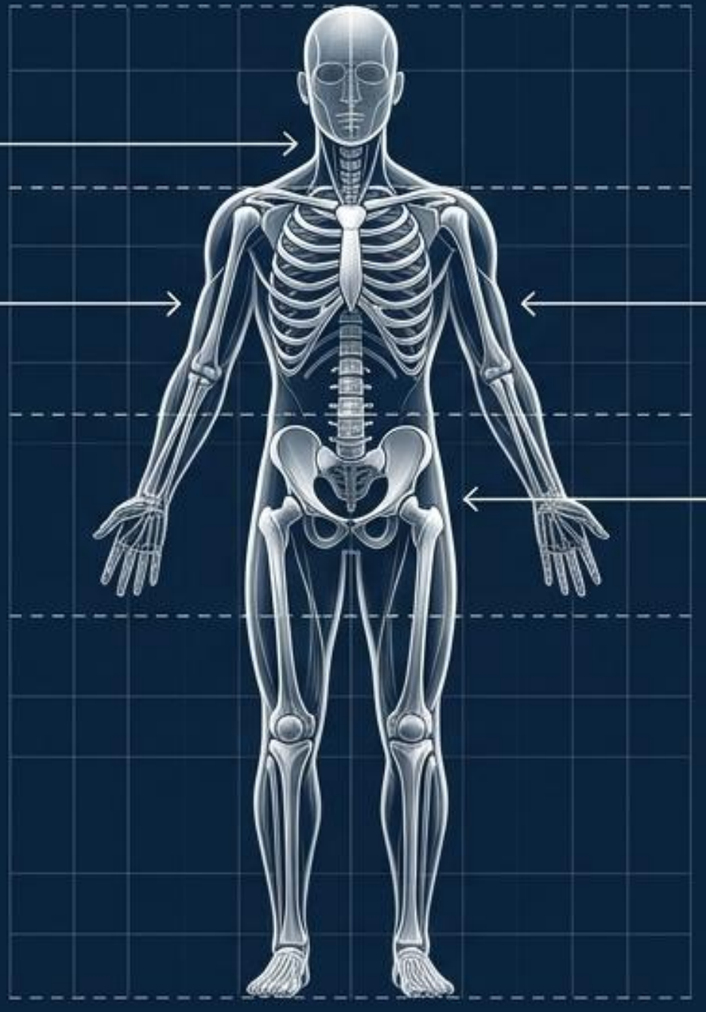
Esperado: Ereta e neutra.

Defeito: Queixo alto, cabeça rodada ou inclinada.

Tórax & Escápulas

Esperado: Tórax levemente para cima/frente. Escápulas de encontro à caixa costal (~10cm de separação).

Defeito: Tórax deprimido, costelas proeminentes.



Membros Superiores

Esperado: Relaxados, palmas voltadas para o corpo, cotovelos levemente flexionados, ombros nivelados.

Defeito: Desnível escapular, rotação interna excessiva.

Pelve & Abdômen

Esperado: Glúteos levemente para baixo, quadris alinhados, abdômen plano.

Defeito: Inclinação pélvica, proeminência abdominal atípica.

Gemini Notebook

Pilar 3: Testes Adicionais – Mensuração de Membros Inferiores

1. Decúbito dorsal, membros estendidos.
2. Pés distantes 15 a 20 cm um do outro e paralelos.
3. Medir a distância entre a face distal da espinha ilíaca anterossuperior e o maléolo (medial ou lateral).

TOLERÂNCIA DIAGNÓSTICA:
Uma diferença de 1,0 a 1,5 cm é considerada fisiológica. Variações maiores podem indicar patologias compensatórias crônicas.



Gemini Notebook

Pilar 3: Testes Adicionais – Teste de Flexão Anterior (Adams)

A Manobra



- - Paciente em pé.
- - Realiza flexão da coluna torácica e lombar.
- - Critério de precisão: Manter o queixo na posição neutra para evitar flexão do pescoço.

O Diagnóstico



- - O fisioterapeuta observa o perfil da coluna em flexão.
- - A presença de assimetria ou uma “proeminência” (giba) em um dos lados do tronco indica a presença de rotação vertebral, sugerindo Escoliose.

Outros testes clínicos comuns incluem o Slump Test (irritação neural) e o Teste de Thomas (encurtamento do iliopsoas).

Gemini Notebook

Diagnóstico Diferencial: Escoliose Não-Estrutural vs. Estrutural

Escoliose Não-Estrutural	Escoliose Estrutural
Características Ósseas	
Nenhuma deformidade óssea presente.	Presença de deformidade óssea (congênita, adquirida ou fraqueza muscular excessiva).
Teste de Flexão	
A curva escoliótica desaparece durante a flexão anterior.	A curva e a assimetria (giba) permanecem durante a flexão.
Progressão e Causas	
Não é progressiva. Causada por má postura, histeria, inflamação ou compensação de pernas curtas.	Progressiva. Presença de deformação morfológica real da coluna.

Gemini Notebook

Síntese de Patologias: Desvios no Plano Sagital



Lordose Patológica
Aumento excessivo da curvatura anterior da coluna.

As 3 Faces da Cifose Patológica



Dorso Curvo
Curva longa e suave



Corcunda / Giba
Curva angular e aguda



Cifose Progressiva
Deterioração estrutural avançada

A postura é a narrativa estrutural do corpo.
Cabe ao fisioterapeuta ler, diagnosticar e intervir.

Gemini Notebook